

		Código	F-MAHC-01
		Versión	2026.1
		Fecha	Agosto 2026
	MANUAL DE AUDITORÍA DE HISTORIA CLÍNICA Y REGISTROS ASISTENCIALES		Hoja 1 De 5

1. INTRODUCCIÓN

La historia clínica (HC) es un documento privado, obligatorio y sometido a reserva, en el cual se registran cronológicamente las condiciones de salud del paciente, los actos médicos y los demás procedimientos ejecutados por el equipo de salud.

La auditoría de la historia clínica para el consultorio psicológico es una herramienta de control de calidad que evalúa la calidad científica, técnica y administrativa de los registros asistenciales, con el fin de garantizar una atención segura, oportuna y conforme a la ley.

2. OBJETIVOS

Objetivo General

Evaluar sistemáticamente la calidad, integridad, veracidad y oportunidad de la complementación de las Historias Clínicas y sus soportes en el Consultorio psicológico, identificando fallas de registro para implementar planes de mejoramiento continuo.

Objetivos Específicos

- Verificar el cumplimiento de la normatividad colombiana vigente en el diligenciamiento de la HC (Resolución 1995 de 1999).
- Garantizar la existencia, diligenciamiento y firma del Consentimiento Informado para cada procedimiento de medicina estética.
- Medir el nivel de adherencia del personal médico a los protocolos y guías de práctica clínica a través de la revisión del registro.
- Diseñar e implementar acciones correctivas y preventivas derivadas de los hallazgos de la auditoría.

3. MARCO LEGAL EN COLOMBIA

El presente manual se fundamenta en el siguiente bloque normativo:

		Código	F-MAHC-01
		Versión	2026.1
		Fecha	Agosto 2026
	MANUAL DE AUDITORÍA DE HISTORIA CLÍNICA Y REGISTROS ASISTENCIALES		Hoja 2 De 5

- **Ley 23 de 1981:** Normas en materia de ética médica (obligatoriedad del registro).
- **Resolución 1995 de 1999:** Por la cual se establecen normas para el manejo de la Historia Clínica.
- **Resolución 1715 de 2005:** Concepto de la Historia Clínica Única y su custodia.
- **Ley 1581 de 2012:** Protección de datos personales (Tratamiento de Datos Sensibles).
- **Resolución 3100 de 2019:** Condiciones de habilitación para prestadores de servicios de salud (Estándar 6: Historia Clínica y Registros).

4. METODOLOGÍA DE LA AUDITORÍA

4.1. Responsable de la Auditoría

La auditoría será liderada por el **Director Médico** o el profesional designado del área de calidad del Consultorio psicologico

4.2. Periodicidad y Muestra

- **Frecuencia:** Trimestral de forma ordinaria (o mensual en caso de alertas de seguridad del paciente).
- **Muestra:** Se seleccionará de forma aleatoria el **10% de las historias clínicas** de pacientes atendidos en el periodo a evaluar, garantizando que se incluyan registros de todos los profesionales activos en la clínica.

4.3. Herramienta de Evaluación

Se aplicará una **Lista de Chequeo de Auditoría de Historia Clínica** estructurada en tres componentes:

1. **Estructura y Diligenciamiento Administrativo** (Datos de identificación).
 2. **Calidad Científico-Técnica** (Contenido asistencial).
 3. **Soportes y Anexos** (Consentimientos, autorizaciones y ayudas diagnósticas).
-

		Código	F-MAHC-01
		Versión	2026.1
		Fecha	Agosto 2026
	MANUAL DE AUDITORÍA DE HISTORIA CLÍNICA Y REGISTROS ASISTENCIALES		Hoja 3 De 5

5. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y LISTA DE CHEQUEO (CHECKLIST)

A continuación se detallan los ítems que se deben calificar como **Cumple (C)**, **No Cumple (NC)** o **No Aplica (NA)**:

Componente	Ítem a Evaluar	Criterio Técnico de Calidad
1. Administrativo	1.1 Identificación Completa	Nombres, apellidos, documento de identidad, edad, sexo, teléfono y contacto de emergencia diligenciados.
	1.2 Fecha y Hora	Todo registro tiene la fecha y la hora exacta de la atención.
	1.3 Identificación del Profesional	Nombre completo, firma y número de registro profesional o tarjeta profesional del médico tratante.
	1.4 Legibilidad y Enmiendas	No hay tachones, borrones, enmendaduras ni espacios en blanco. (Aplica igual para sistemas de software clínico).
2. Clínico	2.1 Motivo de Consulta	Redactado textualmente o sintetizado de forma clara según la queja estética o médica del paciente.
	2.2 Enfermedad Actual	Descripción detallada de la necesidad o motivo, evolución de la condición estética y expectativas.
	2.3 Antecedentes Clínicos	Registro explícito de patologías, cirugías, alergias (enfoque en toxina/ácidos), medicamentos y hábitos.
	2.4 Examen Físico / Estético	Valoración de la piel, asimetrías, clasificación de arrugas, etc., según el tratamiento a realizar.
	2.5 Plan de Tratamiento	Detalle del procedimiento sugerido, dosis tentativas, marcas de insumos y sesiones recomendadas.
	2.6 Registro de Evolución	En citas de control, se describe el progreso, los resultados obtenidos y los cambios observados.
3. Anexos y Soportes	3.1 Consentimiento Informado	Diligenciado en su totalidad, específico para el procedimiento realizado, firmado por paciente y médico.

		Código	F-MAHC-01
		Versión	2026.1
		Fecha	Agosto 2026
	MANUAL DE AUDITORÍA DE HISTORIA CLÍNICA Y REGISTROS ASISTENCIALES		Hoja 4 De 5

Componente	Ítem a Evaluar	Criterio Técnico de Calidad
	3.2 Registro Fotográfico	Presencia de fotografías de "Antes y Después" debidamente almacenadas y autorizadas.
	3.3 Fórmulas y Recomendaciones	Copia de la prescripción de cuidados post-procedimiento entregados al paciente.

6. ESCALA DE CALIFICACIÓN Y NIVELES DE CUMPLIMIENTO

Para procesar los resultados de las listas de chequeo aplicadas, se calculará el porcentaje de cumplimiento mediante la siguiente fórmula:

$$\text{Porcentaje de Cumplimiento} = \left(\frac{\text{Ítems con "Cumple"}}{\text{Total de ítems aplicables (C + NC)}} \right) \times 100$$

El resultado categorizará la calidad de la historia clínica en los siguientes niveles:

- Verde - Excelente (95% - 100%):** Cumplimiento óptimo. Se mantiene vigilancia estándar.
- Amarillo - Aceptable con observaciones (80% - 94.9%):** Requiere retroalimentación verbal al profesional y seguimiento en la siguiente auditoría.
- Rojo - Deficiente / Crítico (Menor a 80%):** Exige la apertura inmediata de un **Plan de Mejoramiento Individual** y reauditoría en 30 días.

7. PLAN DE MEJORAMIENTO CONTINUO

Cuando se detecten fallas reiterativas o una calificación inferior al 95% en los estándares evaluados, el proceso a seguir es:

- Socialización de Resultados:** Reunión con el personal asistencial para exponer los hallazgos sin carácter punitivo, sino pedagógico.
- Análisis de Causas:** Utilizar herramientas como la espina de pescado (Ishikawa) o los "5 porqués" para determinar la raíz del mal diligenciamiento (ej. falta de tiempo, desconocimiento de la norma, fallas en el software).

		Código	F-MAHC-01
		Versión	2026.1
		Fecha	Agosto 2026
	MANUAL DE AUDITORÍA DE HISTORIA CLÍNICA Y REGISTROS ASISTENCIALES		Hoja 5 De 5

- 3. **Plan de Acción:** Establecer compromisos con fechas de ejecución claras (ej. capacitación en consentimiento informado, actualización de plantillas en el software).
- 4. **Seguimiento:** Verificar la efectividad de las acciones en el siguiente ciclo de auditoría.

CONTROL DE CAMBIOS

Versión	Fecha	Descripción del Cambio
1.0	Septiembre 2026	Creación y emisión del manual bajo directrices de la Res. 3100 de 2019.

Proceso: Gestión de la Calidad y Seguridad del Paciente
